

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | دانشکدهٔ پزشکی

جزوهٔ شب امتحانی

آداب پزشکی ۱

- شایستگی‌ها و توانمندی‌های پزشک عمومی
- پروفشنالیسم و تعهد حرفه‌ای
- مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر و گوش دادن فعال
- مهارت‌های مطالعه و یادگیری

مدرسین: دکتر الهام بوشهری · دکتر سمیره عابدینی · دکتر فرحناز کمالی

خلاصهٔ کامل اسلایدها + جزوهٔ دست‌نویس کلاس | ویژهٔ مرور سریع پیش از آزمون

فهرست مطالب و نقشهٔ آزمون

فصل ۱ — شایستگی‌ها و توانمندی‌های پزشک عمومی 3

فصل ۲ — پروفشنالیسم (تعهد حرفه‌ای) 5

فصل ۳ — برقراری ارتباط مؤثر 11

فصل ۴ — مهارت‌های مطالعه و یادگیری 16

فصل ۵ — مرور سریع شب امتحان 18

ارزشیابی و نکات اداری درس

- آزمون پایان‌ترم: کتبی و چهارگزینه‌ای — سؤالات «کیس» (موردی) هم در آزمون می‌آید!
- حضور و غیاب در کلاس بر اساس قوانین آموزشی در نمره لحاظ می‌شود.
- ارتباط با مدرس (دکتر عابدینی): samireha@hums.ac.ir
- در سابجکت ایمیل حتماً ذکر شود: «آداب ۱ مبحث پروفشینالیسم»
- مدرسین: دکتر بوشهری (شایستگی‌ها) · دکتر عابدینی (پروفشنالیسم، ارتباط مؤثر) · دکتر کمالی (مهارت مطالعه)

برنامهٔ جلسات (طرح درس)

هفته	موضوع	مدرس
اول و دوم	معارفه و مقدمات آداب پزشکی، توانمندی‌ها/شایستگی‌های پزشک، روش بارش افکار	دکتر الهام بوشهری
سوم	تاریخچه و مبانی حرفه‌ای‌گری، اصول و قواعد رفتار حرفه‌ای (پروفشنالیسم)	دکتر سمیره عابدینی
چهارم	مبانی ارتباط مؤثر پزشک با بیمار، مهارت گوش دادن فعال	دکتر سمیره عابدینی
پنجم	مهارت‌های مطالعه و یادگیری	دکتر فرحناز کمالی

۱ شایستگی‌ها و توانمندی‌های پزشک عمومی

مدرس: دکتر الهام بوشهری – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تعریف پزشکی

پزشکی شاخه‌ای از علوم کاربردی است که با هدف حفظ و ارتقای سلامت، به تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها می‌پردازد. مقطع دکترای عمومی، پایه و بنیان تمام شاخه‌های تخصصی پزشکی است؛ بنابراین کسب مهارت‌های این دوره هم برای خدمت‌رسانی مناسب به جامعه ضروری است و هم موفقیت در دوره‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مستلزم طی صحیحِ فرایند «طبیب شدن» در همین دوره است.

دانش‌آموختگان پزشکی عمومی چه چیزهایی کسب می‌کنند؟

۱. دانش، هنر و مهارتِ تشخیص، درمان و پیشگیری – از طریق کسب دانش ضروری در علوم پایه و شاخه‌های علوم بالینی
۲. تمرین و ممارست در به‌کارگیری این علوم در مواجهه با بیماران و تکرار مهارت‌های عملی
۳. رشد اجتماعی و حرفه‌ای برای احراز شغل، به موازات کسب دانش و مهارت

جایگاه‌های کاری دانش‌آموختگان

مراکز بهداشتی‌درمانی | مطب خصوصی و بیمارستان | سازمان‌های خدمات سلامت | مراکز آموزشی و تحقیقاتی

محورهای توانمندی (سند توانمندی‌های دکترای پزشکی عمومی)

محور تخصصی

- مهارت‌های بالینی
- مراقبت از بیمار (تشخیص، درمان، بازتوانی)
- ارتقای سلامت و پیشگیری در نظام سلامت و نقش پزشک در آن
- تعهد حرفه‌ای، اخلاق و حقوق پزشکی

محور فردی و شخصی

- مهارت‌های برقراری ارتباط
- مهارت‌های تصمیم‌گیری، استدلال و حل مسئله
- پیشرفت فردی و فراگیری مستمر (یادگیری مادام‌العمر)

مسیر آموزش پزشکی عمومی و شرایط ارتقا

برای کسب صلاحیت‌ها، چهار مرحله طی می‌شود:

۱) علوم پایه | ۲) مقدمات بالینی | ۳) کارآموزی | ۴) کارورزی

گذر از مرحله	شرط ارتقا
ورود به مقدمات بالینی	قبولی در آزمون جامع علوم پایه + میانگین معدل ۱۲ از دروس علوم پایه
ورود به کارورزی (مرحلهٔ چهارم)	قبولی در آزمون جامع پیش‌کارورزی + معدل ۱۲ از مقدمات بالینی و کارآموزی + ثبت موضوع پایان‌نامه
فارغ‌التحصیلی	موفقیت در آزمون عملی صلاحیت بالینی + نمرهٔ قبولی از بخش‌های دوران کارورزی

« نکتهٔ شب امتحان »

عدد طلایی این فصل «معدل ۱۲» است: هم برای ورود به مقدمات بالینی و هم برای ورود به کارورزی. ترتیب چهار مرحله (علوم پایه – مقدمات بالینی – کارآموزی – کارورزی) را حفظ باش؛ گزینه‌سازی رایج آزمون است.

۲ پروفشنالیسم (تعهد حرفه‌ای)

مدرس: دکتر سمیره عابدینی — مبحث اصلی آزمون؛ در سابجکت ایمیل: «آداب ۱ مبحث پروفشینالیسم»

تاریخچهٔ حرفه‌ای‌گری

- قدمت تاریخچهٔ حرفه‌ای‌گری به درازای قدمت طبابت است.
- سقراط حکیم: «اخلاق، برترین و عالی‌ترین سرمایهٔ بشری است.»
- پروفشنالیسم در تمام طول تاریخ طب در قالب سوگندنامه‌های پزشکی وجود داشته است.
- بقراط: اولین کسی که مبانی اخلاقی را با طب در قالب سوگندنامه در هم آمیخت.
- در ایران: اولین بار «برزویهٔ طبیب» رابطهٔ اخلاقی بین پزشک و بیمار را مطرح کرد.
- اخلاق و تعهد حرفه‌ای قدمتی ۲۵۰۰ ساله در آموزش پزشکی دارد؛ اما فقط در ۳۰ سال گذشته به‌صورت رسمی وارد برنامه‌های درسی شده است.

« نکتهٔ شب امتحان »

جفت‌های حفظی: بقراط = سوگندنامه + پیوند اخلاق و طب | برزویه طبیب = اولین در ایران | سقراط = اخلاق برترین سرمایه | ۲۵۰۰ سال قدمت ولی ۳۰ سال ورود رسمی به کوریکولوم.

ریشهٔ واژه و مفاهیم

- پروفشن (profession) از واژهٔ لاتین professio گرفته شده: «اظهارنامهٔ علنی همراه با ضمانتِ اجرای یک تعهد».
- در لاتین، پروفشن در اصل به معنای «حرفهٔ مقدس» است.
- قدیمی‌ترین پروفشن‌ها: طبابت، وکالت، روحانیت، تعلیم‌وتربیت.
- در فارسی «حرفه» معادل پیشه و کسب‌وکار (Business) است؛ کسب‌وکار یعنی فعالیت برای کسب منفعت از فروش کالا یا خدمات — پس حرفه (پروفشن) با کسب‌وکار صرف فرق دارد.

ویژگی‌های حرفه (Profession)

۱. اشتغال یکی از مؤلفه‌های حرفه است.
۲. به‌دست‌آوردن روزی از طریق حرفه است.
۳. برخورداری از دانش، مهارت و توانایی.
۴. پیوند افراد حرفه‌مند بر اساس تعهدات مشترک نسبت به حرفه و جامعه.
۵. خودتنظیمی: اعضا بر خودشان نظارت می‌کنند (self-regulated).
۶. عمل مطابق کدهای اخلاقی – کسب اعتماد جامعه – شأن اجتماعی بالاتر (professional status).

« حواست باشد! »

شأن حرفه‌ای حقِ ذاتی یا موروثی نیست؛ امتیازی است که «جامعه» اعطا می‌کند و ابقای آن به باورِ جامعه به قابل‌اعتماد بودن اعضای حرفه بستگی دارد. جامعه در عوض انتظار دارد منافع سلامتی بیمار و جامعه بر منافع شخصی مقدم باشد.

تعاریف پروفشنالیسم / تعهد حرفه‌ای

منبع	تعریف
دیکشنری آکسفورد	استاندارد بالایی که از فردِ خوب‌آموزش‌دیده در یک شغل خاص انتظار می‌رود.
سویک (Swick)	مجموعه‌ای از رفتارها که پزشکان نشان می‌دهند ارزشِ اعتمادِ اعطاشده از طرف جامعه و بیماران را دارند.
کالج سلطنتی بریتانیا	مجموعه‌ای از ارزش‌ها، رفتارها و ارتباطات که باعث اعتماد مردم به پزشکان می‌شود.
بورد تخصص‌های پزشکی آمریکا	یک سیستم اعتقادی که در آن حرفه‌مندان به یکدیگر و به جامعه اعلان می‌کنند ارزش‌های اخلاقی و استانداردهای شایستگیِ قول‌داده‌شده را در عمل به کار می‌بندند.

ویژگی‌های فرد حرفه‌ای (۶ ویژگی — قلب فصل!)

۱) نوع‌دوستی: در پیِ بهترین منافع بیمار باشد، نه منفعت شخصی

- ارجحیت منافع بیمار بر منافع خود · توجه به خواسته‌های بیمار
- صرف وقت و حوصله برای توضیح اطلاعات و آرامش‌بخشیدن به بیمارِ ناخوش
- تلاش برای کاستن رنج و درد بیمار از تمام راه‌های ممکن · گوش‌دادن دلسوزانه به نگرانی‌ها
- مشارکت در سازمان‌های حرفه‌ای محلی و ملی · پیشنهاد کمک به اعضای تیم · داوطلب‌شدن برای کار همکارِ ناتوان از انجام کار

۲) تعالی شغلی: یادگیری علم و مهارت پزشکی در تمام طول زندگی حرفه‌ای

- جست‌وجوی فعالِ فیدبک و اصلاح رفتار/عملکرد بر اساس آن
- نگرش نقادانه به خود؛ تشخیص حیطه‌های نیازمند ارتقاء
- شناختن محدودیت‌های خود و کمک‌گرفتن از دیگران در موارد ناکافی‌بودن دانش و مهارت
- ارزیابی سلامتی جسمی، روحی و معنوی خود · احساس مسئولیت برای بازآموزی
- شرکت در راندها، سمینارها و سایر فعالیت‌های آموزشی

۳) وظیفه‌شناسی: انجام کامل و به‌موقع وظایف

- به‌موقع رسیدن · قابل‌اعتماد بودن · پیروی از سرپرست · رعایت ضوابط و مقررات
- پاسخ به‌موقع به نامه‌ها، احضارها، تلفن‌ها و ایمیل‌ها
- همکاری مناسب در کار تیمی · در دسترس بودن در زمان آنکال (on call)
- اظهار خطای پزشکی به تیم یا سرپرست · اظهار وجود تعارض منافع به تیم یا سرپرست

۴) شرافت و درستکاری: انصاف، صداقت و درستی در تعاملات

- رفتار صادقانه (راستگویی، انصاف، رک بودن، خوش‌قول بودن)
- حل اختلافات با حفظ احترام به شأن طرف مقابل
- رفتار مناسبِ شأن پزشکی در رفتار، صحبت، لباس‌پوشیدن و آراستگی
- صداقت با بیماران و اجتناب از بزرگ‌نمایی توانمندی‌های خود
- تشویق موفقیت همکاران در اجتماعات عمومی · اظهارنظر فقط در حیطهٔ تخصص خود
- عدم مشارکت در تقلب (دادن و گرفتن) در آزمون‌ها · پذیرفتن مسئولیت کار خود

۵) احترام به دیگران: بیمار و خانواده، همکاران، دانشجویان، دستیاران و فلوها

- برقراری تفاهم با اعضای تیم · حفظ حریم‌های لازم در موقعیت‌های شغلی و آموزشی
- معرفی خود و اعضای تیم به بیمار و خانواده‌اش · مورد خطاب قراردادن بیمار به شکل مناسب
- استفاده از اصطلاحات قابل‌فهم برای بیمار
- حفظ شأن انسانی بیمار و خانواده، چه در حضور و چه در غیاب ایشان
- ارتباط خوب با دانشجویان در محیط آموزشی

۶) عدالت: ارائهٔ عادلانهٔ خدمات و رفع تبعیض

- توزیع عادلانهٔ منابع · مراقبت از منابع · طبابت بر اساس هزینه‌اثربخشی

« نکتهٔ شب امتحان »

ترفند حفظ ۶ ویژگی: «نوع‌دوستی، تعالی، وظیفه‌شناسی، شرافت، احترام، عدالت» — برای هر ویژگی حداقل دو مصداق بلد باش؛ سؤالِ «کدام مصداق مربوط به کدام ویژگی است؟» بسیار محتمل است. مثلاً «اظهار خطای پزشکی» – وظیفه‌شناسی، ولی «عدم تقلب» – شرافت و درستکاری!

اخلاق پزشکی از دیدگاه محمدبن زکریای رازی

حوزه	خلاصهٔ دیدگاه رازی
حرفهٔ پزشکی	وارستگی و آراستگی در ظاهر و رفتار، رازداری، مطالعه، پرهیز از اتلاف وقت در کارهای بیهوده، عدم استفاده از طبابت به‌عنوان تجارت، اعتمادبه‌نفس مناسب و احترام به بیمار.
امور پژوهشی	رعایت اخلاق در پژوهش، وجه ممتاز رازی است: ذکر مأخذِ هر جمله و نقل‌قول؛ حتی تصریح به «نویسندهٔ مجهول» برای مطالب بی‌مأخذ.
امور درمانی	تعهد به اخلاق، دقت و امانت در هر اقدام درمانی؛ هیچ‌گاه نباید پیش از شناسایی عاملِ درد، داروی ضددرد تجویز کرد — اول شناسایی عامل، بعد زدودن آن.

چالش‌های رفتار حرفه‌ای (۷ دسته)

۱) سوءاستفاده از قدرت ۲) تکبر ۳) طمع ۴) اظهار نادرست

۵) ناتوانی **۶) نبود وجدان کاری** **۷) تعارض منافع**

۱) سوءاستفاده از قدرت — خودش ۳ زیرشاخه دارد!

احترامِ دیرینهٔ جامعه به پزشکی، قدرت زیادی به پزشک می‌دهد؛ استفادهٔ مناسب از آن منشأ کارهای مفید است، اما سوءاستفاده از آن پایه‌گذار «هنجار غلط» برای رفتار حرفه‌ای می‌شود. سه مصداق:

- ارتباط با بیمار و همکاران: اجازه‌ندادن به بیمار برای بیان خواسته‌ها یا شرکت در تصمیم‌گیری؛ اثرگذاری رقابت‌های دانشگاهی/مالی بر ارزیابی صادقانه از همکار یا دانشجو؛ استفاده از همکار جوانِ رده‌پایین برای پیشرفت آکادمیک خود؛ به‌تأخیرانداختن عمدی پیشرفت همکار و بدنام‌کردن او.
- نقض رازداری: اطلاعات بیمار باید کاملاً محرمانه بماند؛ بحث دربارهٔ جزئیات وضعیت بیمار در جمع (آسانسور شلوغ، مهمانی!) سوءاستفاده است. افشای راز فقط وقتی مجاز است که مصالح بیمار حکم کند یا ضرورت قانونی باشد.
- تبعیض: همهٔ همکاران باید بدون درنظرگرفتن ناتوانی، قومیت، جنسیت، نژاد و مذهب بتوانند به سمت پتانسیل‌هایشان پیشرفت کنند؛ حذف بی‌انصافی‌های کوچک و بزرگ مسئولیت اعضای حرفه است.

۲) تکبر

تظاهر ناخوشایند برای برتری و جلوه‌دادن خود؛ موجب غرور، خودبینی، توهین و تحقیر می‌شود. آموزشِ طولانی و دشوار پزشکی، دانشجو را مستعد باور «خودبزرگ‌بینی» می‌کند.

> **« حواست باشد! »**
>
> تکبر تعهد حرفه‌ای را از «سه» طریق نابود می‌کند: ۱) کاهش توانایی فکرکردن پزشک به عملکرد خود؛ ۲) مشکل‌شدن همدردی با بیماران؛ ۳) از بین بردن نقش مفیدِ «شک به خود». — این سه مورد حفظی و سؤال‌خیز است!

۳) طمع

- وقتی پول عاملِ هدایت‌کنندهٔ طبابت شود، طمع غالب شده و تعهد حرفه‌ای به فساد کشیده می‌شود.
- طمع می‌تواند آرزوی ناشایستِ شهرت، قدرت یا پول باشد.
- با طمع، نوع‌دوستی، مراقبت، بخشش و درستکاری کمرنگ می‌شوند.
- حذف طمع مستلزم «تشخیص» آن و درمانش مستلزم «خودکاوی مداوم» دربارهٔ انگیزه است: عملکردم تحت هدایت منافع بیمار است یا منافع شخصی؟

۴) اظهار نادرست (بی‌صداقتی)

- شامل دروغگویی و فریب است.
- دروغگویی: با آگاهی حرفِ راست را نگوییم — اقدامی تعمدی.
- فریب: اظهار نادرست و عمدیِ یک واقعیت با هدف گمراه‌کردن افراد.
- دروغ به‌طور کلی به نفع بیمار نیست، حتی وقتی به‌قصد کمک به او باشد!
- مثال فریب: اظهار نادرستِ داده‌های آزمایشگاهی یا مداخلات پژوهشی.

۵) ناتوانی

- پزشکی که توانایی‌اش آسیب دیده باید از مسئولیت‌پذیری در مراقبت از بیماران صرف‌نظر کند؛ همکاران هم باید مراقب حفظ استانداردها باشند.
- اختلال کار «همه یا هیچ» نیست: درجات شدید به‌راحتی قابل تشخیص‌اند ولی موارد خفیف و حدمرزی شاید نه.
- هر پزشک باید آموزش ببیند تا انواع ناتوانی را (مخصوصاً در مراحل اولیه) تشخیص دهد و راهکارهای مداخله را بشناسد.

- ناتوانیِ ناشی از سوءمصرف مواد، وابستگی به دارو، الکلیسم، دمانس یا بیماری روانی عمدتاً فراتر از توانایی تشخیصِ خودِ پزشکِ آسیب‌دیده است.
- دلیل‌تراشی برای اقدام‌نکردن دربارهٔ همکار ناتوان = خارج‌شدن از رفتار حرفه‌ای.

۶) نبود وجدان کاری = عدم انجام مسئولیت‌ها

- خلاصه‌ترین شرح‌حال را می‌گیرد · به‌جای دیدن خودِ رادیوگرافی، منتظر گزارش رادیولوژی می‌ماند.
- به تلفن بستگان بیمار جواب نمی‌دهد · به‌جای دیدن بیمار، چارت پزشکی او را می‌بیند.
- آخرین اطلاعات را به‌جای منابع معتبر علمی از نمایندهٔ شرکت دارویی می‌گیرد · دیر سر راند حاضر می‌شود.
- مراقبت بیماران را به کارآموزانِ آماده‌نشده (بدون سرپرستی استاد) محول می‌کند.
- سؤال‌های آسان را انتخاب می‌کند · در کمیتهٔ کاری‌اش شرکت نمی‌کند یا در جلسه هست ولی در بحث شرکت نمی‌کند.

۷) تعارض منافع

شرکت در موقعیت‌های تعارض منافع یعنی حمایت از منافع فردی و فداکردن منافع بیمار و جامعه به نفع منفعت پزشک.

« نکتهٔ شب امتحان »

هفت چالش را با جمله‌ی رمز به خاطر بسپار: «سوء + تکبر + طمع + دروغ + ناتوانی + بی‌وجدانی + تعارض». زیرشاخه‌های سوءاستفاده از قدرت (ارتباط، رازداری، تبعیض) را جدا حفظ کن — در آزمون معمولاً مصداق می‌دهند و دسته را می‌خواهند.

۳ برقراری ارتباط مؤثر

مدرس: دکتر سمیره عابدینی — بر پایهٔ کارگاه دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی

چرا ارتباط مهم است؟

- برقراری ارتباط «اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی» است.
- انسان حیوانی اجتماعی است؛ یکی از برتری‌های انسان بر سایر جانداران، تنوع و گسترهٔ وسیع ارتباطاتی است که می‌تواند ایجاد کند.

مهارت ارتباطی و صلاحیت بالینی

چهار جزء ضروری صلاحیت‌های بالینی (Clinical Competence):

۱) مهارت‌های ارتباطی **۲) دانش نظری** **۳) حل مسئله** **۴) معاینهٔ فیزیکی**

- مهارت ارتباطی جزء کلیدی و محوری صلاحیت بالینی است؛ بدون آن، سه صلاحیت دیگر به‌راحتی از دست می‌روند.
- مهارت ارتباطی «ساقهٔ درخت» مهارت بالینی است.
- مهارت ارتباطی صفت شخصی/ذاتی نیست؛ باید آن را آموخت — و باید به‌طور مؤثر و کارآمد آموخت.
- ارتباط در پزشکی فقط به شخصیت پزشک بستگی ندارد و مثل سایر علوم پزشکی قابل آموزش است.
- کلید یادگیری یک مهارت پیچیده: تقسیم آن به قسمت‌های مختلف، یادگرفتن خوبِ هر قسمت، سپس به‌هم‌چسباندن آن‌ها.

چرا تدریس مهارت ارتباطی مهم است؟ (اعداد حفظی!)

- مصاحبه با بیمار جزء مهمی از طبابت روزانه است؛ یک پزشک در طول عمر طبابت بیش از ۲۰۰,۰۰۰ ویزیتِ همراه با مصاحبه انجام می‌دهد.
- برای بیمار، ملاقات با پزشک حساس‌ترین و پراضطراب‌ترین ملاقات وی در طول یک هفته است.

پژوهشگر (سال)	یافتهٔ کلیدی
Stewart (1979)	۵۴٪ از شکایت‌های بیماران و ۴۵٪ از دغدغه‌های آنان در مصاحبه کشف نمی‌شود یا پزشکان به آن توجه نمی‌کنند.
Starfield (1981)	در نیمی از مصاحبه‌ها، پزشک و بیمار بر سر ماهیت بیماری توافق ندارند.
Beckman & Frankel (1984)	رویکرد پزشکان در گردآوری اطلاعات عمدتاً پزشک‌محور و بسته است؛ بیماران تمایلی به افشای همهٔ اطلاعات پیدا نمی‌کنند. اغلب پزشکان کلام بیمار را پیش از پایان قطع می‌کنند.
Tuckett (1985)	پزشکانی که عقاید و انتظارات بیماران را بشنوند یا اجازهٔ بیان نظرات بدهند، چندان زیاد نیستند.
Hadlow (1991)	پزشکان عباراتی به کار می‌برند که بیماران معنای آن را نمی‌فهمند.

تعریف و ارکان ارتباط

- ارتباط: هرگونه تعاملی که شامل «انتقال پیام» باشد.
- فرایند دوطرفه شامل فرستادن و دریافت پیام + بازخورد؛ پیام می‌تواند کلامی یا غیرکلامی باشد.

اهمیت ارتباط (۸ مورد)

۱. تنها وسیلهٔ انتقال اطلاعات به دیگران
۲. تنها وسیلهٔ دریافت اطلاعات از دیگران
۳. انتقال عاطفه به دیگران از طریق ارتباط
۴. تصحیح سوءبرداشت‌ها و سوءتفاهم‌ها فقط از طریق ارتباط
۵. مهار هیجان‌های منفی (مثل خشم) تنها از طریق ارتباط سالم
۶. بلوغ یک اجتماع منوط به سیّالیِ ارتباط‌های بین‌فردی
۷. ارتباط، دستمایهٔ هر نوع رشد فردی و اجتماعی
۸. تمام آسیب‌های فردی و اجتماعی ریشه در ارتباط ناسالم دارند

عناصر و اجزای ارتباط

عناصر اصلی: «کلامی» و «غیرکلامی».

اجزای کلامی	اجزای غیرکلامی
محتوای کلام	تُن صدا
توجه به ابعاد فرهنگی و خرده‌فرهنگی	آهنگ صدا
چگونگی شروع صحبت	تماس چشمی
نحوهٔ جمله‌بندی	حالات چهره‌ای
زمان‌بندی ارتباط کلامی	ژست‌ها
ملاحظات موقعیتی	حالات بدنی
چگونگی جمع‌بندی و ختم ارتباط	–

گوش دادن فعال

«شنیدن» با «گوش دادن فعال» فرق دارد؛ گوش دادن فعال به اندازهٔ حرف‌زدن و یا حتی بیشتر از آن انرژی مصرف می‌کند.
مهارت‌های دریافت پیام = مهارت همدلی + مهارت گوش دادن فعال.

اهداف گوش دادن (۶ مورد)

راهنمایی گرفتن | درک دیگران | حل مشکلات
فهمیدن احساسات دیگران | حمایت عاطفی دیگران | کسب اطلاعات

روش‌های مؤثر برای گوش دادن فعال (۶ روش)

۱. توجه کردن به فرد مقابل
۲. سؤال کردن
۳. بازخورد دادن
۴. با عباراتی دیگر بازگو کردن
۵. خلاصه نمودن
۶. مدیریت فرایند ارتباط

شرح روش‌ها

- توجه به فرد مقابل: بیشترین تماس چشمی با گوینده؛ استفاده از واژه‌ها و اصوات نشانهٔ توجه (بله، آهان، متوجه‌ام، تکان‌دادن سر، لبخند)؛ کمی متمایل‌شدن به گوینده با حالت بدنی آسوده و حداقلِ جنبش؛ تکرار ظریف نشانه‌های غیرکلامی و کلماتِ گوینده؛ حرف بیرون کشیدن از گوینده («مایلم بیشتر بدانم»)؛ توجه به چیزهایی که گفته نشده‌اند؛ دقت به «چگونه گفتن» (هیجان و نگرش پشت کلمات از خود کلمات مهم‌تر است)؛ کمتر صحبت‌کردن؛ قطع‌نکردن کلام در اوایل صحبت.
- سؤال کردن – ۳ هدف: ۱) نشان می‌دهد به صحبت‌های راوی گوش می‌کنید؛ ۲) وسیلهٔ خوبی برای جمع‌آوری و سازمان‌بندی اطلاعات است؛ ۳) روشی برای ابرازِ آنچه اگر غیرسؤالی مطرح می‌شد جنبهٔ موعظه/درس کلاسی/نصیحت پیدا می‌کرد. (سؤال باز بهتر از بسته!)
- بازخورد دادن: راهی برای بررسی درستیِ برداشت شما در زمان مکث گوینده؛ از یک‌سو محکِ شنیده‌ها و دیده‌های شماست و از سوی دیگر به گوینده کمک می‌کند دریابد احساسش را درست منتقل کرده یا نه. نشانهٔ بازخورد درست: تأیید فرد مقابل («بله، همین‌طور است»).
- بازگوکردن با عباراتی دیگر: تکرار چند کلمهٔ آخر یا واژه‌های کلیدیِ گوینده با عبارتی دیگر؛ صورت‌بندی مجدد باعث معلوم‌شدن اصل موضوع، برداشته‌شدن بار منفی صحبت و تداوم ارتباط می‌شود و جملات موقعیتی را به جملات مربوط به علایق و نیازها ترجمه می‌کند.
- خلاصه کردن: تکرار هستهٔ اصلی صحبت و تأکید بر نکات مهم، مخصوصاً وقتی یک قسمت صحبت تمام شده و می‌خواهیم به قسمت دیگر برویم.
- مدیریت فرایند ارتباط: مرتبط با موضوع پیش‌بروید و اول اجازه دهید صحبت گوینده تمام شود؛ از سکوت نهراسید – سکوت یک «سرنخ» در فرایند کلامی است که اطلاعات فراوانی می‌دهد.

خصوصیات گوش دادن فعال (۹ مورد)

۱. اختصاص زمان بیشتر به گوش دادن به‌جای صحبت کردن
۲. عدم تکمیل جملات دیگران
۳. عدم پاسخ به سؤال با یک سؤال دیگر
۴. آگاه بودن از سوگیری‌های شخصی
۵. نپرداختن به تخیل و عدم اشتغال ذهنی با مسائل دیگر
۶. عدم سلطه‌جویی در مکالمه
۷. پاسخ دادن به فرد مقابل پس از پایان یافتن صحبت‌های وی
۸. دادن بازخورد
۹. پرسیدن سؤالات باز

رمزهای پنج‌گانهٔ ارتباط درمانی

رمز	یعنی
کامل بودن	همهٔ اطلاعات ضروری را داشته باشد.
روشن بودن	اطلاعات موجود در پیام واضح باشد.
مختصر بودن	شامل اطلاعات غیرضروری نباشد.
مودبانه بودن	ارتباط درمانی همیشه باید مودبانه باشد.
منسجم بودن	پیام منسجم: منطقی و همراه با نظم و ترتیب.

« نکتهٔ شب امتحان »

رمز حفظی: «کامل، روشن، مختصر، مودبانه، منسجم» = ۵ میم‌وکاف! این پنج‌تا را عیناً با تعریفشان حفظ کن؛ جای خالی یا جفت‌کردنِ تعریف‌ها سؤال کلاسیک است.

رفتارهای غیرکلامی مناسب در ارتباط (۵ مورد)

۱. حفظ تماس چشمی
۲. تکان دادن سر
۳. لبخند و نشان دادن علاقه
۴. متمایل شدن به سمت گوینده
۵. استفاده از تُن صدای متناسب با پیام

برای گوش‌دادن غیرکلامی: چهره را به سمت گوینده بچرخانید، از همهٔ گیرنده‌های بدن (مخصوصاً چشم‌ها — از بهترین ابزارهای دریافت پیام) استفاده کنید و به پیام‌های غیرکلامی گوینده بازخورد دهید.

توصیه‌ها برای ارتباط کلامی کارآمدتر (هنگام صحبت کردن)

- مطمئن شوید شنونده فرصت سؤال یا اظهارنظر دارد · خود را جای شنونده بگذارید و احساساتش را در نظر بگیرید.
- آنچه می‌خواهید بگویید واضح بیان کنید · به شنونده نگاه کنید.
- گفتارتان با تُن صدا و زبان بدنی‌تان هماهنگ باشد · تُن و آهنگ صدا را تغییر دهید.
- مبهم صحبت نکنید و با جزئیات زیاد موضوع را پیچیده نکنید · از دیدن علائم آشفتگی در شنونده غفلت نکنید.

توصیه‌هایی برای افزایش کیفیت گوش دادن فعال (۱۰ مورد)

۱. ابراز آنچه می‌خواهید، بیان کنید (واضح ابراز کنید)
۲. اشاره به جنبه‌های مثبت موضوع و فرد
۳. اظهارنظر مشخص و متمرکز
۴. استفادهٔ کمتر از واژه‌های کلیِ مبهم (مثل «این» و «آن»)

۵. تمرکز بر «رفتارِ» فرد، نه بر خودِ فرد
۶. پرداختن به رفتارهایی که قابل تغییرند
۷. بازخوردِ توصیفی بدهید، نه قضاوتی و ارزشیابانه
۸. بازخورد با اول‌شخص مفرد و ضمیر «من»
۹. استفادهٔ کمتر از واژه‌هایی مثل «همیشه» و «هرگز»
۱۰. حتی‌الامکان نصیحت نکنید — به فرد کمک کنید به درک بهتری از موضوع و جایگاه خودش برسد

موانع ارتباط

موانع ارتباط (۷ مورد)

کلیشه‌های اطمینان‌بخش | پند دادن / تأکید کردن | توضیح خواستن | تحقیر / انتقاد کردن
دفاع کردن | تغییر موضوع | شرمسار کردن

موانع موجود بر سر راه ارتباط مؤثر (۸ مورد)

قضاوت کردن | ارجاع به خود | بی‌توجهی به احساسات فرد مقابل | قطع کردن صحبت
ارائهٔ راه‌حل | مسخره کردن | تهدید کردن | برچسب زدن

« نکتهٔ شب امتحان »

جملهٔ طلایی پایان کارگاه: «کودک انسان ظرف دو سال صحبت‌کردن را می‌آموزد؛ اما گاهی شصت سال طول می‌کشد تا کسی گوش‌کردن را بیاموزد.» — احتمال نقل مستقیم در آزمون!

۴ مهارت‌های مطالعه و یادگیری

مدرس: دکتر فرحناز کمالی — بر اساس جزوهٔ دست‌نویس کلاس

چرا استراتژی مطالعه را بهبود دهیم؟

راه‌های افزایش ظرفیت یادگیری

- انگیزه
- داشتن هدف روشن

نتایج بهبود استراتژی مطالعه (۳ مورد)

۱. صرفه‌جویی در وقت
۲. کاهش حجم کاری
۳. کمک به بهبود کیفیت کار

محرک‌های یادگیری بیشتر (۵ مورد)

۱. علاقه به یادگیری
۲. تمایل به موفقیت در امتحان پایان‌ترم
۳. انجام کار و تمرین
۴. تأیید، تحسین و پاداش‌دهی دیگران
۵. فشارهای بیرونی

نیازهای دانشجوی پزشکی (۵ مورد)

۱. نیازمند تلاش آگاهانه و حساب‌شده در طول زمان برای یادگیری مطالب
۲. نیاز به یادگیری تکنیک‌های جدید مطالعه و یادگیری
۳. نیاز به اولویت‌بندی مطالب
۴. یادگیری منظم و پویا
۵. نیاز به یادگیری مادام‌العمر

سطوح مختلف دانش (۶ سطح)

۱) دانستن | ۲) فهمیدن | ۳) به‌کار گرفتن
۴) تجزیه و تحلیل | ۵) ترکیب کردن | ۶) ارزشیابی

« نکتهٔ شب امتحان »

ترتیب سطوح (هرم بلوم) را از ساده به پیچیده حفظ باش: دانستن – فهمیدن – به‌کارگیری – تجزیه‌وتحلیل – ترکیب – ارزشیابی.

مغز و حافظه

نیمکره	کارکرد
لوب چپ مغز	منطق، حقایق، به‌یادآوری مطالب
لوب راست مغز	احساسات، عواطف و تصورات فردی

- قانون سه‌تایی‌ها برای حافظه: مرور در «سومین روز، سومین هفته، سومین ماه».
- مدل شبکهٔ معنایی: قدرت حافظه به درجهٔ همبستگیِ مطالب جدید با مطالب قبلی وابسته است.
- مراحل یادگیری فعال: قبل از یادگیری – در طول یادگیری – بعد از یادگیری.
- یکی از رایج‌ترین روش‌های یادگیری فعال، «یادداشت‌برداری» است.

۵ مرور سریع شب امتحان

همهٔ اعداد، اسم‌ها و لیست‌های حفظی در یک نگاه

اعداد طلایی

عدد	کجا بود؟
۲۵۰۰ سال	قدمت اخلاق و تعهد حرفه‌ای در آموزش پزشکی
۳۰ سال	ورود رسمی اخلاق حرفه‌ای به برنامه‌های درسی پزشکی
معدل ۱۲	شرط ارتقا به مقدمات بالینی و به کارورزی
۲۰۰,۰۰۰ ویزیت	تعداد ویزیت‌های همراه با مصاحبه در عمر طبابت یک پزشک
۵۴٪ و ۴۵٪	شکایت‌ها و دغدغه‌های کشف‌نشدهٔ بیماران (Stewart 1979)
۵۰٪ (نیمی)	مصاحبه‌هایی که پزشک و بیمار بر ماهیت بیماری توافق ندارند (Starfield 1981)
۲ سال / ۶۰ سال	یادگیری حرف‌زدن کودک / یادگیری گوش‌کردن!
روز ۳، هفته ۳، ماه ۳	قانون سه‌تایی‌های حافظه (زمان‌های مرور)

چه کسی، چه کرد؟

نام	نقش / گفته
سقراط حکیم	اخلاق، برترین و عالی‌ترین سرمایهٔ بشری است
بقراط	اولین پیونددهندهٔ مبانی اخلاقی با طب در قالب سوگندنامه
برزویهٔ طبیب	اولین مطرح‌کنندهٔ رابطهٔ اخلاقی پزشک و بیمار در ایران
رازی	اخلاق در حرفه + پژوهش (ذکر مأخذ) + درمان (اول شناسایی عامل درد، بعد داروی ضددرد)
سویک (Swick)	تعریف تعهد حرفه‌ای: رفتارهایی که نشان می‌دهد پزشکان ارزش اعتماد جامعه را دارند
موتابی و فتی	مدرسان کارگاه روش‌های برقراری ارتباط مؤثر

لیست‌های حفظی در یک نگاه

لیست	اعضا
۴ جزء صلاحیت بالینی	مهارت ارتباطی (ساقهٔ درخت!) · دانش · حل مسئله · معاینهٔ فیزیکی
۴ مرحلهٔ دورهٔ پزشکی	علوم پایه · مقدمات بالینی · کارآموزی · کارورزی

لیست	اعضا
۶ ویژگی فرد حرفه‌ای	نوع‌دوستی · تعالی شغلی · وظیفه‌شناسی · شرافت و درستکاری · احترام به دیگران · عدالت
۷ چالش رفتار حرفه‌ای	سوءاستفاده از قدرت · تکبر · طمع · اظهار نادرست · ناتوانی · نبود وجدان کاری · تعارض منافع
۳ زیرشاخهٔ سوءاستفاده از قدرت	ارتباط با بیمار و همکاران · نقض رازداری · تبعیض
۳ راه تخریب تعهد توسط تکبر	کاهش فکرکردن به عملکرد خود · سخت‌شدن همدردی · حذف «شک به خود»
۵ رمز ارتباط درمانی	کامل · روشن · مختصر · مودبانه · منسجم
۶ روش گوش دادن فعال	توجه · سؤال · بازخورد · بازگویی با عبارات دیگر · خلاصه‌کردن · مدیریت فرایند
۶ هدف گوش دادن	راهنمایی‌گرفتن · درک دیگران · حل مشکلات · فهم احساسات · حمایت عاطفی · کسب اطلاعات
۷ مانع ارتباط	کلیشهٔ اطمینان‌بخش · پند/تأکید · توضیح‌خواستن · تحقیر/انتقاد · دفاع · تغییر موضوع · شرمسارکردن
۸ مانع ارتباط مؤثر	قضاوت · ارجاع به خود · بی‌توجهی به احساسات · قطع صحبت · ارائهٔ راه‌حل · مسخره‌کردن · تهدید · برچسب‌زدن
۶ سطح دانش	دانستن · فهمیدن · به‌کارگیری · تجزیه‌وتحلیل · ترکیب · ارزشیابی

چک‌لیست نهایی قبل از خواب

- [ ] تعریف پزشکی و ۳ دستاورد دانش‌آموختگان را می‌دانم.
- [ ] شرایط ارتقای هر مرحله (مخصوصاً معدل ۱۲) را بلدم.
- [ ] ریشهٔ واژهٔ profession و ۴ پروفشن قدیمی را بلدم.
- [ ] ۶ ویژگی فرد حرفه‌ای را با مصداق‌هایشان جفت می‌کنم.
- [ ] ۷ چالش رفتار حرفه‌ای + ۳ زیرشاخهٔ سوءاستفاده از قدرت را حفظم.
- [ ] دیدگاه رازی در ۳ حوزه (حرفه، پژوهش، درمان) را می‌دانم.
- [ ] آمارهای Beckman & Frankel، Tuckett، Starfield، Stewart و Hadlow را با سال و عدد بلدم.
- [ ] ۵ رمز ارتباط درمانی و ۶ روش گوش دادن فعال را حفظم.
- [ ] موانع ارتباط (۷تایی و ۸تایی) را قاطی نمی‌کنم.
- [ ] قانون سه‌تایی‌های حافظه و سطوح ۶گانهٔ دانش را بلدم.

موفق باشی!